Fluxogramas Terapeuticos

AC1 - 7o Periodo - Esquemas com Posologia

Classificar/Avaliar | Tratar/Medicar | Desfecho/Meta | CI/Alerta

1. ASMA

ASMA

Diagnostico confirmado por espirometria com reversibilidade

▼

Avaliar Controle (GINA)

Sintomas diurnos, despertares, limitacao, uso de resgate

▼

Step 1-2

ICS-Formoterol sob demand

Via 1 (preferencial): dose baixa PRI

- **Budesonida-formoterol** 200/6 mcg por inalaca
- Usar conforme necessidade (resgate + anti-infla
- Via 2 (alternativa): ICS dose baixa diario + SAB

▼

Reavaliar em 4-12 semanas

Step 3

ICS-Formoterol manutencao + re

Estrategia MART - dose baixa

- **Budesonida-formoterol** 200/6 mcg 1-2x/dia + F
- Mesmo inalador para manutencao e resgate
- Alternativa: ICS dose media + SABA

▼

Reavaliar controle

Step 4-5

ICS-Formoterol dose media/alta

MART dose media; Step 5: encaminhar

- **Step 4:** ICS-formoterol dose media MART
- **Step 5:** adicionar LAMA (tiotropio 5 mcg/dia)
- Ou biologico: anti-IgE (omalizumabe), anti-IL5 (mepoli
- Fenotipagem: eosinofilica vs. alergica vs. nao-tipo 2

▼

NUNCA

SABA isolado (sem ICS) em nenhum step. LABA isolado e CONTRAINDICADO (aumento de mortalidade)

2. DPOC

DPOC
VEF1/CVF < 0,7 pos-BD confirmado

▼

Classificar - Grupos GOLD ABE
mMRC/CAT (sintomas) + exacerbacoes no ultimo ano

▼

Grupo A	Grupo B	Grupo E
mMRC 0-1, CAT <10	**mMRC >=2 ou CAT >=10**	**>=2 exac/ano ou >=1 com internacao**
Sem exacerbacoes	Sem exacerbacoes	Exacerbador
▼	▼	▼
BD de curta PRN	**LABA + LAMA**	**LABA + LAMA +/- ICS**
SABA ou SAMA conforme necessida	Broncodilatacao dupla de manutenca	Adicionar ICS se eosinofilos >= 300
■ **Salbutamol** 200-400 mcg inalacao PRN ■ **Ipratropio** 40-80 mcg inalacao PRN	■ **Formoterol + glicopirronio** ou ■ **Indacaterol + glicopirronio** ou ■ **Tiotropio** 5 mcg/dia + **formoterol** 12 mcg 2x/dia	■ **LABA + LAMA** como base (ver Grupo B) ■ Se eosinofilos >= 300: adicionar **ICS** (terapia tripla) ■ Se eos <100 e infeccoes: azitromicina profilatica

▼

Exacerbacao Aguda
BD curta + corticoide + ATB se purulento

■ **Prednisona** 40 mg VO por 5 dias
■ **ATB** se escarro purulento (amoxicilina-clav ou azitromicina)
■ **VNI (BiPAP)**: 1a escolha se pH <7,35 + pCO_2 elevada
■ IOT apenas se falha da VNI ou rebaixamento

▼

ICS isolado NAO tem papel na DPOC
Diferente da asma: ICS so em combinacao e se eosinofilos elevados

3. INSUFICIENCIA CARDIACA

INSUFICIENCIA CARDIACA

Sintomas + anormalidade estrutural/funcional. BNP/NT-proBNP

▼

Classificar pela FEVE

Ecocardiograma

▼

ICFEr <= 40%

Terapia Quadrupla

Iniciar TODOS precocemente, titular ate d

- **1) ARNI:** sacubitril-valsartana 49/51 -> 97/103 m
- Washout 36h se vindo de IECA
- **2) BB:** carvedilol 3,125 -> 25 mg 2x/dia
- metoprolol succ. 12,5 -> 200 mg 1x/dia
- bisoprolol 1,25 -> 10 mg 1x/dia
- **3) ARM:** espironolactona 25-50 mg 1x/dia
- **4) iSGLT2:** dapagliflozina ou empagliflozina 10 mg 1x/dia

▼

Meta: FEVE recuperada

NAO suspender (TRED-HF: 44% recidiva com retirada)

ICFEi 41-49%

iSGLT2 + tratar comorbidade

Evidencia crescente p/ terapia semelhante

- **iSGLT2:** dapagliflozina ou empagliflozina 10 mg
- Diuretico se congestao
- Considerar BB, IECA/BRA e ARM individualmen

ICFEp >= 50%

iSGLT2 + controle PA + diuretico

EMPEROR-Preserved, DELIVER

- **iSGLT2:** dapagliflozina ou empagliflozina 10 mg
- Controle rigoroso da PA (<130/80)
- Diuretico para congestao (furosemida)
- ARM se necessario

▼

Evitar

BCC nao di-hidropiridinico em ICFEr (inotropismo -). Nunca IECA + ARNI simultaneos

4. HIPERTENSAO ARTERIAL

HIPERTENSAO ARTERIAL

PA consultorio >= 140/90 mmHg confirmada (MAPA/MRPA)

▼

Meta: < 130/80 mmHg

Para praticamente todos os pacientes (DBHA 2025)

▼

Iniciar com Combinacao Dupla

NAO iniciar monoterapia (exceto idoso fragil)

- **Opcao 1:** IECA/BRA + tiazidico
- **Opcao 2:** IECA/BRA + BCC
- **Opcao 3:** BCC + tiazidico
- Preferir comprimido unico (combinacao fixa)

▼

PA na meta?

Reavaliar em 4 semanas

▼

Sim

Manter e monitorizar

Alto risco: 3/3 meses. Baixo risco: 6/6 meses

Nao - escalonar

Terapia Tripla

IECA/BRA + BCC + tiazidico em doses otimizadas

- **Enalapril** 5-40 mg ou **losartana** 25-100 mg
- **Anlodipino** 2,5-10 mg
- **HCTZ** 12,5-25 mg ou clortalidona 12,5-25 mg ou indapamida 1,5-2,5 mg

▼

Ainda fora da meta com 3 classes?

Excluir pseudorresistencia (adesao, avental branco, AINEs)

▼

4o Farmaco: Espironolactona

HA Resistente (PATHWAY-2)

- **Espironolactona** 12,5-50 mg 1x/dia
- Monitorar K+ e creatinina em 7-14 dias

▼

5o-6o Farmacos

HA Refrataria (>=5 classes incluindo ARM)

- **BB:** carvedilol, nebivolol, bisoprolol
- **Simpatolitico central:** clonidina 0,1-0,3 mg 2-3x/dia
- **Alfa-bloqueador:** doxazosina 1-16 mg/dia
- **Vasodilatador:** hidralazina 25-100 mg 2-3x/dia (+ BB + diuretico de alca obrigatorios)

▼

Nunca associar IECA + BRA

ONTARGET: hipercalemia + IRA, sem beneficio adicional

5. CRISE HIPERTENSIVA

CRISE HIPERTENSIVA

PA acentuadamente elevada

▼

Ha lesao aguda de orgao-alvo?

Encefalopatia, EAP, SCA, disseccao, eclampsia, IRA aguda?

▼

SIM - Emergencia

UTI + Farmaco IV titulavel

Reduzir 20-25% na 1a hora -> 160/100 em 2-6h

- **Nitroprussiato:** 0,25-10 mcg/kg/min
- **Nitroglicerina:** 5-200 mcg/min (SCA, EAP)
- **Esmolol:** 500 mcg/kg bolus + 25-50 mcg/kg/min
- **Metoprolol IV:** 5 mg a cada 5 min (max 15 mg)
- **Furosemida:** 20-60 mg IV (apenas se congestao)

▼

Cenario especifico?

NAO - Urgencia

Medicacao VO

Reducao gradual em 24-48h

- **Captopril** 25-50 mg VO
- **Clonidina** 0,1-0,2 mg VO
- **Anlodipino** 5-10 mg VO
- Ajustar esquema ambulatorial

▼

Alta com ajuste ambulatorial

Reavaliar em 7 dias

▼

Cenarios Especificos da Emergencia:

Disseccao

Disseccao Aorta

PAS 100-120, FC <60 em 20 min

- **BB PRIMEIRO** (esmolol ou metoprolol IV)
- Depois vasodilatador (nitroprussiato)
- **NUNCA** vasodilatador antes de BB
- Hidralazina CONTRAINDICADA

Eclampsia

Eclampsia

Gestacao

- **Hidralazina IV:** 5-10 mg (1a escolha)
- **MgSO4:** anticonvulsivante (NAO e anti-hiperten
- **IECA/BRA:** CONTRAINDICADOS (teratogenico
- Nitroprussiato CONTRAINDICADO (cianeto feta
- Tratamento definitivo: PARTO

AVC

AVC Isquemico

Sem trombolise

- **Hipertensao permissiva:** tratar so se >220/120
- Com trombolise: meta <185/110 antes, <180/105 apos
- Evitar queda agressiva da PA

6. DOENCA ULCEROSA PEPTICA

DOENCA ULCEROSA PEPTICA

Dor epigastrica + EDA com ulcera gastrica ou duodenal

Investigar Etiologia

Testar H. pylori (TODOS) + anamnese ativa para AINEs/aspirina

H. pylori | **AINEs** | **Idiopatica**

H. pylori (+)

Causa mais comum

Terapia Tripla (1a linha)

IBP dose alta 2x/dia + 2 ATB por 14 d

- **IBP** (omeprazol 20 mg, esomeprazol 40 mg) 2x/
- **Amoxicilina** 1 g VO 2x/dia
- **Claritromicina** 500 mg VO 2x/dia
- Duracao: **14 dias** (7 dias NAO e mais aceito)
- Usar se resistencia local a claritromicina <15%

Terapia Concomitante (quadrupla s/ bismuto)

Se resistencia desconhecida ou >15% a claritro

- **IBP** dose alta 2x/dia
- **Amoxicilina** 1 g VO 2x/dia
- **Claritromicina** 500 mg VO 2x/dia
- **Metronidazol** 500 mg VO 2x/dia
- Duracao: **14 dias** - taxa 85-90%

AINEs (+)

Suspender AINE + testar H. pylori

IBP dose padrao 1x/dia

4-8 semanas conforme tamanho

- **Omeprazol** 20 mg 1x/dia ou equivalente
- Se necessario manter AINE: IBP de manutenca
- Erradicar H. pylori se coinfeccao

Idiopatica

H. pylori (-) e AINE (-)

IBP dose padrao

UD 4 sem / UG 8 sem

- **Omeprazol** 20 mg 1x/dia
- Investigar causas raras (Zollinger-Ellison)
- Recorrencia ~24%: IBP manutencao longo prazo

Resgate: Quadrupla com Bismuto

2a linha ou alergia a penicilina / falha tripla

- **IBP** dose alta 2x/dia
- **Bismuto** 120-300 mg VO 4x/dia
- **Metronidazol** 250-500 mg VO 4x/dia
- **Tetraciclina** 500 mg VO 4x/dia
- Duracao: **14 dias** (min 10d) - taxa 85-90%

Confirmar Erradicacao

>=4 sem apos ATB + >=2 sem sem IBP. TRU ou antigeno fecal (sorologia NAO serve)

COMPLICACOES

Hemorragia	Perfuracao	Estenose
Hemorragia (mais comum) Hematemese, melena, instabilidade	**Perfuracao (2-10%)** Dor subita + rigidez + taquicardia	**Estenose Pilorica** Vomitos pos-prandiais tardios + perda de peso
▼	▼	▼
Hemostasia Endoscopica Forrest IA/IB/IIA = alto risco ■ **IBP IV:** omeprazol 80 mg bolus + 8 mg/h por 72 ■ Depois IBP VO dose alta 2x/dia ■ Forrest IIA (vaso visivel): ressangramento ~43% ■ Forrest III (base limpa): baixo risco (~5%)	**Cirurgia de Urgencia** Pneumoperitonio na TC ■ Rafia simples (omentopl.) + lavagem ■ IBP IV + ATB de amplo espectro ■ **Cuidado:** melhora paradoxal da dor	**IBP dose alta + Dilatacao** Endoscopica por balao ■ **IBP dose alta** (reduz edema peri-ulcera) ■ Dilatacao endoscopica com balao ■ Cirurgia se refrataria (vagotomia + piloroplastia) ■ Alcalose metabolica hipocloremica

▼

IBP + ARH2 NAO melhora cicatrizacao

Nao associar. Sempre testar H. pylori em ulcera complicada.
UG: EDA controle 8-12 sem (excluir Ca)

7. DRESS

DRESS
Suspeitado: exantema + febre + envolvimento sistemico + farmaco de risco (2-8 semanas)

▼

Calcular RegiSCAR Score
Febre, linfadenopatia, eosinofilia, linfocitos atipicos, exantema >=50% SC, biopsia, orgao, duracao >=15d

▼

RETIRAR farmaco culpado imediatamente
Proscrever CLASSE INTEIRA

▼

Classificar Gravidade
Extensao cutanea + envolvimento visceral

▼

Leve	Moderado	Grave
Exantema sem envolvimento vis	**Exantema extenso +/- envolvimen**	**Hepatite, nefrite, pneumonite, hemofagoc**
▼	▼	▼
Corticoide Topico Alta potencia (grupos 1-2) ■ **Clobetasol** 0,05% creme 2-3x/dia ■ **Betametasona** 0,05% ■ **Mometasona** 0,1%	**Corticoide Topico Grupo 1 OU Sis** Desmame >= 3 meses ■ Topico grupo 1 se cutaneo predominante ■ Ou **prednisona** 0,5 mg/kg/dia com desmame gr	**Prednisona Sistemica** Desmame LENTO obrigatorio ■ **Prednisona** 0,5-1 mg/kg/dia VO ■ Manter ate melhora clinica + laboratorial ■ Desmame lento: 8-12 semanas ■ **NAO usar pulsoterapia** (OR 4,7 mortalidade)
		▼
		Refratario a corticoide?
		▼
		Ciclosporina Se nao houver envolvimento renal/DRC ■ **Ciclosporina** 3-5 mg/kg/dia VO 2x/dia por 7 dias ■ Desmame em 7-14 dias ■ **CONTRAINDICADA** se nefrite ou DRC

▼

IGIV NAO recomendada. Ganciclovir apenas se PCR alta + dano viral confirmado
Desmame rapido -> flare (reativacao HHV-6)

8. TETANO

TETANO

Diagnostico CLINICO: trismo + rigidez + espasmos generalizados

1. Neutralizar Toxina

Imunoglobulina + vacina

- **IGHAT (terapeutico):** 3.000-6.000 UI IM
- **IGHAT (profilaxia):** 500 UI IM
- Se indisponivel: **SAT** 20.000-30.000 UI (risco anafilaxia)
- **Vacina dT** durante internacao (tetano NAO confere imunidade)

2. Debridamento Cirurgico

1-6h APOS imunoglobulina

3. Antibiotico

Eliminar C. tetani - reduzir producao de toxina

- **1a escolha: Metronidazol** 500 mg IV 8/8h
- **Alternativa:** penicilina cristalina (mas pode aumentar espasmos - antagonismo GABA)

4. Controle de Espasmos

Sedacao + relaxamento muscular

- **Diazepam** 1-10 mg/kg/dia IV fracionado
- **Midazolam** em infusao continua se refratario
- **Baclofeno intratecal** em casos selecionados
- BNM (rocuronio) se espasmos incontrolaveis com VM

5. Via Aerea

Traqueostomia PRECOCE - 24h

- **Traqueostomia** preferida sobre IOT
- IOT causa manipulacao laringea -> desencadeia espasmos de glote
- Necessidade de VM prolongada (semanas)

6. Disautonomia

Instabilidade hemodinamica + arritmias

- **MgSO4:** 40 mg/kg bolus + 2 g/h por 7 dias
- **Opioides:** morfina/fentanil em infusao
- **Alfa-2 agonistas:** clonidina/dexmedetomidina

EVITAR BB puros

Podem causar parada cardiaca subita por atividade simpatica sem oposicao - usar apenas labetalol (alfa+beta) se necessario

9. INJURIA RENAL AGUDA

INJURIA RENAL AGUDA

Elevacao de creatinina e/ou oliguria

Estadiar - KDIGO

Est 1: Cr >=0,3 em 48h ou 1,5-1,9x. Est 2: 2-2,9x. Est 3: >=3x ou >=4 ou TRS

Identificar Etiologia

Pre-renal vs. Intrinseca vs. Pos-renal - historia + sedimento + imagem

SHR-AKI

Cirrotico + ascite + Cr elevac

Nao responde a albumina, NaU <1(

Terlipressina + Albumina

Vasoconstritor esplancnico

- **Terlipressina** 0,5-1 mg IV 4-6/6h
- **Albumina** 20-40 g/dia IV
- Alternativa: noradrenalina se indisponivel
- Tratamento definitivo: transplante hepatico

Leptospirose

IRA + ictericia + mialgia

Fase imune da leptospirose

Penicilina Cristalina

Antibioticoterapia precoce

- **Penicilina cristalina** 1,5 milhao UI IV 6/6h
- Alternativa: ceftriaxona 1 g IV 1x/dia
- Suporte dialitico se necessario

Rabdomiolise

CPK >>10x + mioglobinuria

Trauma, exercicio, drogas

Expansao Volemica Agressiva

Prevenir NTA por mioglobina

- **SF 0,9%** 200-300 mL/h
- Meta: diurese 200-300 mL/h
- Monitorar K+, Ca2+, fosforo

Indicacao de Dialise de Urgencia?

Mnemonico AEIOU

Dialise se Refratario

A.E.I.O.U

- **A**cidose metabolica refrataria (pH <7,1)
- **E**letrolitos - hipercalemia com ECG (K+ >6,5 + alteracoes)
- **I**ntoxicacao por substancia dialisavel
- **O**verload - hipervolemia/EAP refratarios a diuretico
- **U**remia sintomatica (encefalopatia, pericardite)

Triple Whammy: IECA + BRA + AINE

Colapso da TFG em hipovolemia - suspender AINE, nao associar IECA+BRA